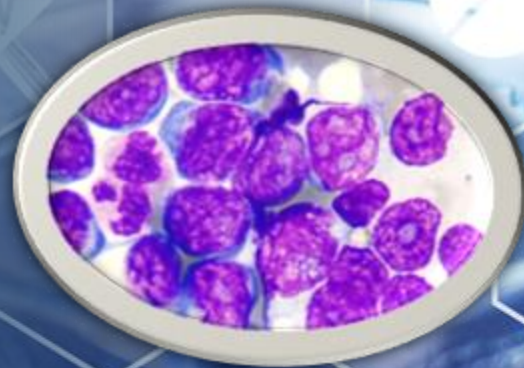




МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



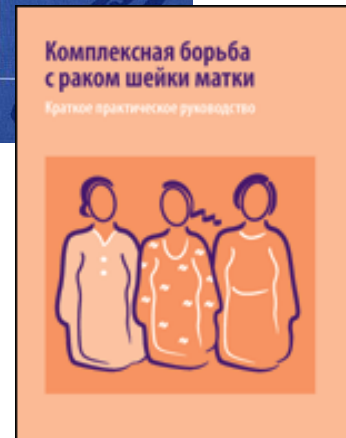
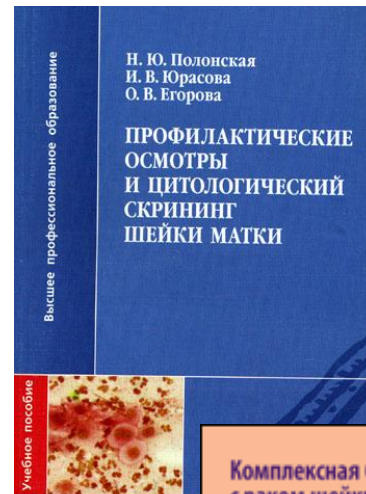
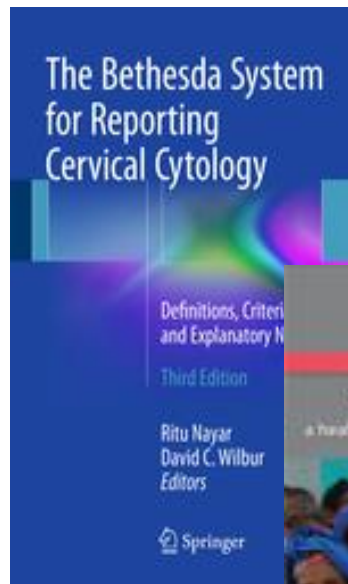
**Цитологическая диагностика:
- современные программы и
перспективные направления скрининга,
- хронометраж исследований.**

25 сентября 2025

Вострикова Ж.И.

Что же такое скрининг?

- скрининг (от англ. *screening* — массовое обследование) — комплекс мероприятий в системе здравоохранения, проводимых с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения





Программы скрининга



Снижению риска смерти от рака:

80–90%

0-20%

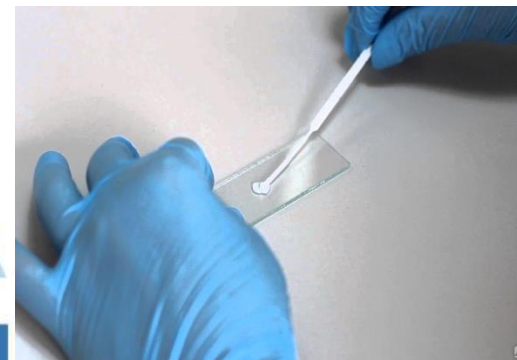
35–60%

0-30%

20%

исследования
продолжаются

исследования
продолжаются





Хороший скрининговый тест должен быть

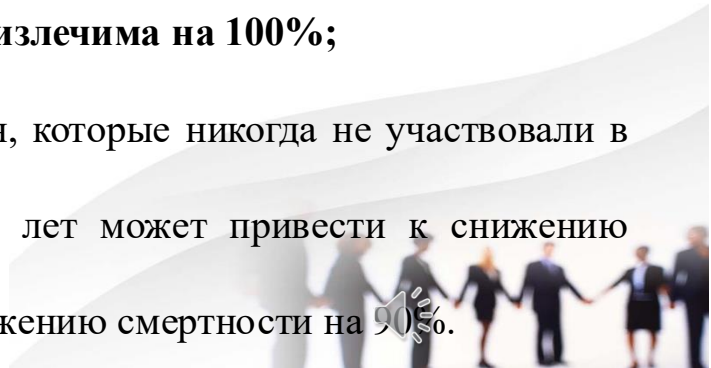
- ❖ точным,
- ❖ легко воспроизводимым,
- ❖ недорогим,
- ❖ простым в исполнении,
- ❖ доступным и безопасным.

Чтобы быть эффективным скрининговый тест должен обладать достаточной специфичностью, чувствительностью, высокой прогностической ценностью и соответствовать основным задачам скрининга: первая - определение популяции потенциальной по риску развития, и вторая – снижение заболеваемости и смертности.

Скрининг на рак шейки матки – тестирование среди условно здоровых женщин, не имеющих патологических симптомов

■ Ранняя стадия поражения шейки матки излечима на 100%;

- Заболевание раком развивается в течении 7-15 лет;
- Риск развития инвазивного рака в 5-10 раз выше у женщин, которые никогда не участвовали в скрининге;
- Скрининг женщин в возрасте 25-64 лет с интервалом 5 лет может привести к снижению смертности на 84%;
- Скрининг в возрасте 25-63 лет с интервалом в 3 года – к снижению смертности на 90%.

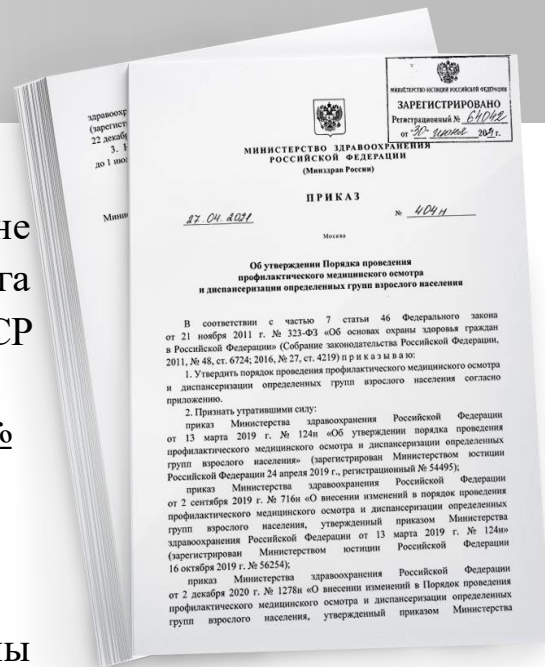




Регламент скрининга???

Существующие в нашей стране нормативные документы также не дают однозначного ответа относительно времени начала скрининга РШМ и временного интервала между ними. Так, приказ МЗ СССР №1253 от 30.12.76 предписывал начинать скрининг с **18 лет**, приказ МЗ РФ №50 от 10.02.2003 г. – с **30 лет**, а приказ МЗ РФ №103 от 2002 г. «О проведении целевой диспансеризации в Москве» – с **35 лет**.

В настоящее время регламент по данной диагностике в рамках Приказов №1130н и №404н. В РФ нет Национальной программы цервикального скрининга, документы МЗ РФ ограничиваются несколькими предложениями и реально в России проводится **неорганизованный или добровольный скрининг**, в котором участвует от **14 до 30%** женского населения, а межскрининговый интервал колеблется от **1 года до 5 лет и более**.



**Приказ Минздрава России от 20.10.2020
N1130н
"Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю
"акушерство и гинекология"
(Зарегистрировано в Минюсте России
12.11.2020 N 60869)**

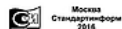


Письмо Министерства здравоохранения РФ от 2 ноября 2017 г. N 15-4/10/2-7676 О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) "Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака"



Диагностика в онкологии
СКРИНИНГ
Рак шейки матки

Издание официальное



Диагностика в онкологии
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ
Шейка матки
Лабораторный этап

Издание официальное



Клинические рекомендации – Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки – 2020-2021-2022 (31.05.2021) – Утверждены Минздравом РФ

Клинические рекомендации – Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки – 2020-2021-2022 (31.05.2021) – Утверждены Минздравом РФ

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: N86, N87
Год утверждения (частота пересмотра): 2020
Возрастная категория: Взрослые
Год окончания действия: 2022
ID: 597

Разработчик клинических рекомендаций

- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
- Российское общество акушеров-гинекологов

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ





Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"

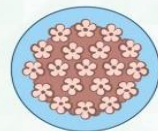
В соответствии с [пунктом 11 части 2 статьи 14](#) и [пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2019, N 52, ст.7770)



**В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ ОСМОТР ГИНЕКОЛОГОМ
1 РАЗ В ГОД**

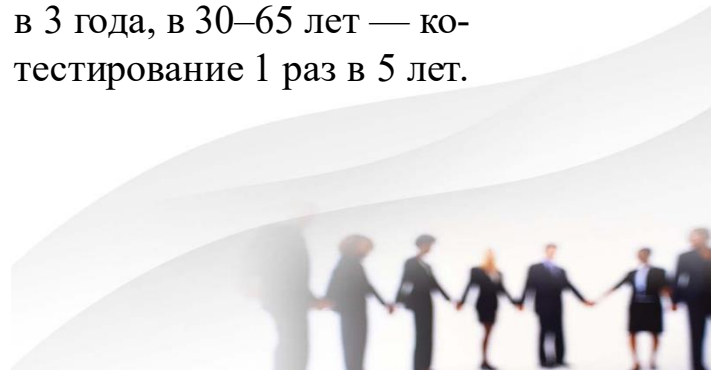


**В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 64 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЗЯТИЕ
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МАЗКА С ШЕЙКИ МАТКИ
(ТЕСТ ПАПАНИКОЛАУ) 1 РАЗ В 3 ГОДА**



**В ВОЗРАСТЕ 30 ЛЕТ АНАЛИЗ НА ВИРУС
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) 1 РАЗ В 5 ЛЕТ**

Приказом №1130н регламентировано, что в возрасте 21–29 лет пациенткам следует назначать цитологию/жидкостную цитологию 1 раз в 3 года, в 30–65 лет — ко-тестирование 1 раз в 5 лет.





Всемирной организацией здравоохранения рассматриваются 4 варианта методик цервикального скрининга:

- 1 ПАП-тест с традиционным мазком (традиционная цитология, ТЦ)
- 2 ПАП-тест с жидкостной пробоподготовкой (т.н. жидкостная цитология, ЖЦ)
- 3 ВПЧ тестирование молекулярными методами
- 4 Кольпоскопия



РАК ЯИЧНИКОВ

Отсутствие данных по патогенезу и достоверных причинах развития патологии не позволяет проводить полноценную профилактику рака яичников.

Больные этой патологией имеют очень низкую пятилетнюю выживаемость.

35%

Основная профилактика – это выявление болезни на раннем этапе.

Самостоятельно заподозрить развитие опухоли невозможно: на начальных этапах она растет бессимптомно и не причиняет боль.

Необходимо ежегодно проходить профилактический осмотр у гинеколога. Позднее выявление влияет на пятилетнюю выживаемость.



Но замечено, что у женщин с большим количеством детей, рак яичников развивается крайне редко. Поэтому в профилактику можно включить лечение патологий, приводящих к бесплодию, и несколько беременностей, завершившихся родами.



РАК ШЕЙКИ МАТКИ

Профилактика рака шейки матки у женщин репродуктивного возраста должна проводиться с первого посещения гинеколога.

С целью профилактики необходимо ежегодно проходить осмотр у врача. Женщинам любого возраста раз в год обязательно берется мазок на онкоцитологию. Он позволяет определить наличие атипичных клеток и провести углубленную диагностику тем, кому это нужно.

Факторы риска развития рака шейки матки

- раннее начало половой жизни;
- частая смена половых партнеров;
- отказ от барьерного метода контрацепции;
- использование оральных контрацептивов;
- курение;
- наличие инфекций, передающихся половым путем;
- иммунодефицитные состояния.

Болезни, которые могут перейти в рак или стать для него благоприятным фоном

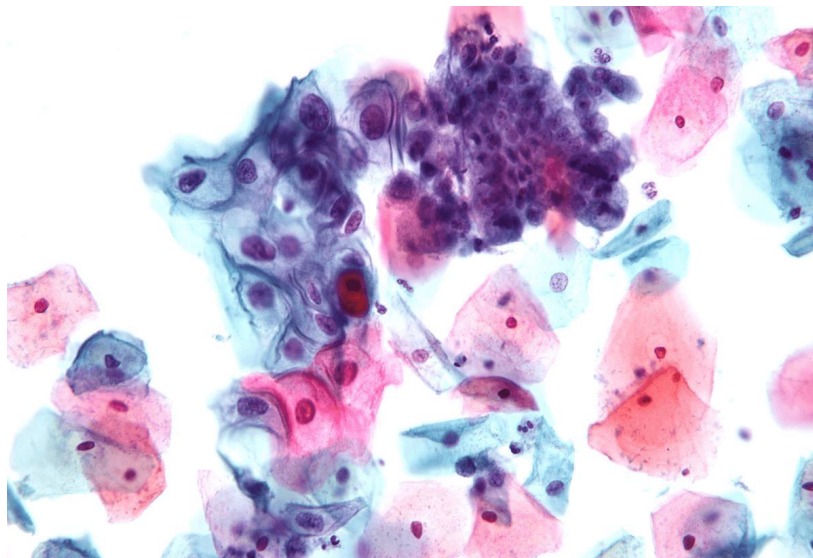
- эрозия шейки матки;
- лейкоплакия;
- эритроплакия;
- дисплазия различной степени;
- эктропион;
- полип;
- эндометриоз;
- цервицит;
- папиллома.





ЖЦ признана наиболее информативным методом скрининга заболеваний ШМ, рекомендованным ВОЗ в качестве «золотого стандарта» для исследований цервикальных мазков.

ЖЦ используется в скрининговых программах в некоторых странах и регионах Европы (в частности Великобритании), США, Австралии.





ПРОГРАММА организованного скрининга.

1. Активное привлечение женщин на основе регистра населения.
2. Сохранение существующих и создание новых смотровых кабинетов и ЦЦЛ.
3. Осуществление двухступенчатого цитологического исследования мазков ШМ: цитотехнолог/лаборант и врач КЛД/цитопатолог.
4. Передача информации в территориальное координационное учреждение. Направление пациенток с выявленной патологией в профильные медучреждения.
5. Обеспечение и контроль качества скрининга (внутрилабораторный, межлабораторный, федеральный)
6. Организация обучения специалистов, занимающихся данной программой.





проект АКЦР 2018г. Попытка №2...

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Ю.К. ГАУХОВА, Н.Н. ВОЛЧЕНКО

Актуальность (заболеваемость и смертность от рака шейки матки в России и в мире)

Рак шейки матки (РШМ) занимает четвертое место по частоте возникновения и смертности среди всех злокачественных новообразований после рака молочной железы, колоректального рака и рака лёгких (согласно данным Международного агентства по изучению рака, 2012 г.).

В 2012 г. в мире РШМ заболело 528000 и умерло 266 000 женщин. Наибольшее число случаев (70%) данной патологии по-прежнему приходится на страны Азии и Африки с низким уровнем экономического развития. Так, по данным того же агентства, ежегодно в странах Экваториальной Африки выявляется 34,8 новых случаев заболевания РШМ и 22,5 случа-

живные формы РШМ составляют около 30%. Одной из основных причин смертности в этом возрасте является РШМ, занимая 2-ое место после рака молочной железы. Данный факт особенно тревожен, так как эта группа женщин наиболее активна в репродуктивно значимой части населения, а также в социальном отношении.

Приведенные выше данные в отношении стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуации требуют принятия масштабных профилактических мер. Методы ранней диагностики и профилактики РШМ могут способствовать существенному улучшению ситуации.

К мерам **первичной профилактики** РШМ относятся: вакцинация против ВПЧ девочек 9-13 лет, санитарное просвещение и предупреждения о вреде





Требования к бланку

1. Приказ МЗ РФ № 464н от 2021г «Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований (с изменениями на 23 ноября 2021 года)»
2. Приказ МЗ РФ № 174 от 2003г «Об утверждении учетных форм для цитологических исследований» (формы 203/у-02 "Направление на цитологическое диагностическое исследование и результат исследования« и 446/у "Направление на цитологическое исследование и результат исследования материала, полученного при профилактическом гинекологическом осмотре, скрининге")
3. Приказ МЗ РФ № 255 от 2004г «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» (изменения в ред. Приказов МЗ РФ от 2014 № 834н, 2018 № 2н, от 2020 № 1186н, от 2024 № 190н)*
4. Ф3-323 от 2011г «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

*– важно тем, кто работает в рамках ОМС в программах межучрежденческих взаимодействий (как аутсорсерным МО)

Дата поступления материала

1. Качество препарата адекватный, недостаточно адекватный, неадекватный
(нужное подчеркнуть)
2. Цитограмма (нужное отметить):
 - 2.1. Без особенностей (для репродуктивного возраста) (дать описание):
.....
 - 2.2.С возрастными изменениями слизистой оболочки
 - атрофический тип мазка;
 - эстрогенный тип мазка;
2. Цитограмма (описание).....
-
- соответствует (нужное отметить):
 - 2.1. Прролиферации (гиперлазии) железистого эпителия.
 - 2.2. Гиперкератозу плоского эпителия.
 - 2.3. Воспалительному процессу слизистой оболочки (вагинит, эктоцервицит, эндоцервицит) уточнить:
 - степень выраженности.....
 - этиологический фактор.....
 - 2.4. Бактериальному вагинозу.
 - 2.5. Атрофическому кольпиту.
 - 2.6. Нерезко выраженным изменениям клеток плоского эпителия:
 - легкой дисплазии;
 - изменениям характерным для папилломавирусной инфекции.
 - 2.7. Выраженным изменениям клеток плоского эпителия (уточнить):
 - умеренной дисплазии;
 - тяжелой дисплазии.
 - 2.8. Раку (уточнить форму).....
 3. Другие типы цитологических заключений:

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 255

Назад Кнопки: Распечатать Скачать В избранное Поиск в тексте

Редизайн от 15.12.2014 — Документ не действует Показать изменения

Инструкция по заполнению учетной формы N 057/У-04 "Направление на госпитализацию, обследование, консультацию"

(в. ред. Приказа Минздрава РФ от 15.12.2014 N 834н)

Приложение 11 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 N 255

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 057/У-04 "НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИЮ"

Варианты бланков: заключение обязано быть только по системам TBS / The Bethesda System IV (Бетезда)



ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование	Результат
Исследуемый материал	Соскобы с шейки матки и цервикального канала
День цикла	7
Место забора	Экзоцервикс
Качество препарата	Адекватный
Цитогарма	В мазке клетки поверхностного и промежуточного слоев, расположенные в скоплениях и разрозненно без особенностей.
Цитологическое заключение (экзоцервикс)	Цитогарма в пределах нормы. NILM
Место забора эндоцервикс	Эндоцервикс
Качество препарата	Адекватный
Цилиндрический эпителий	Обнаружены скопления цилиндрического эпителия с признаками пролиферации, с образованием сосочковых и железистых структур.
Цитологическое заключение (эндоцервикс)	Цитогарма в пределах нормы. NILM

Комментарий:

Обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ИСО 15189:2009, ИСО 15189:2012. Сертификат соответствия выдан на основании протокола внутреннего аудита.

Из Приказа МЗ РФ № 464н

«При проведении цитологических исследований результатом исследования является цитологический диагноз, который формулируется с использованием цитологических и гистологических терминов в соответствии с международными классификациями и МКБ»

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
Цитологическое исследование соскоба шейки матки			
Качество препарата	адекватный		
Цитогарма	.		
Цитогарма (описание)	.		
Цитогарма представлена клетками плоского эпителия без признаков атипии.			
Лейкоцитарная реакция	незначительная		
Специфический инфекционный агент	не обнаружен		
Цитогарма соответствует	в пределах нормы (NILM)		
В пол. матер. клетки с признаками злокачественности	не обнаружены		
Дополнительное уточнение	отсутствует		
Фамилия И.О. врача, проводившего исследование			
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала			
Качество препарата	адекватный		
Цитогарма	.		
Цитогарма (описание)	.		
Цитогарма представлена клетками плоского и цилиндрического эпителия без признаков атипии.			
Лейкоцитарная реакция	незначительная		
Специфический инфекционный агент	не обнаружен		
Цитогарма соответствует	в пределах нормы (NILM)		
В пол. матер. клетки с признаками злокачественности	не обнаружены		
Дополнительное уточнение	отсутствует		
Фамилия И.О. врача, проводившего исследование			

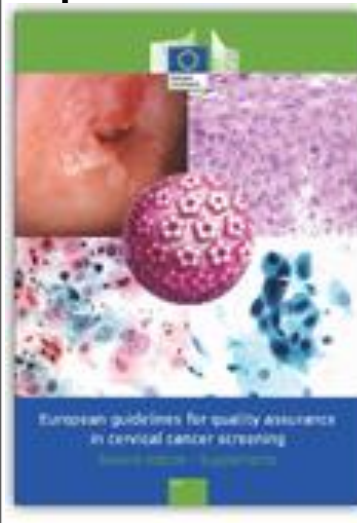
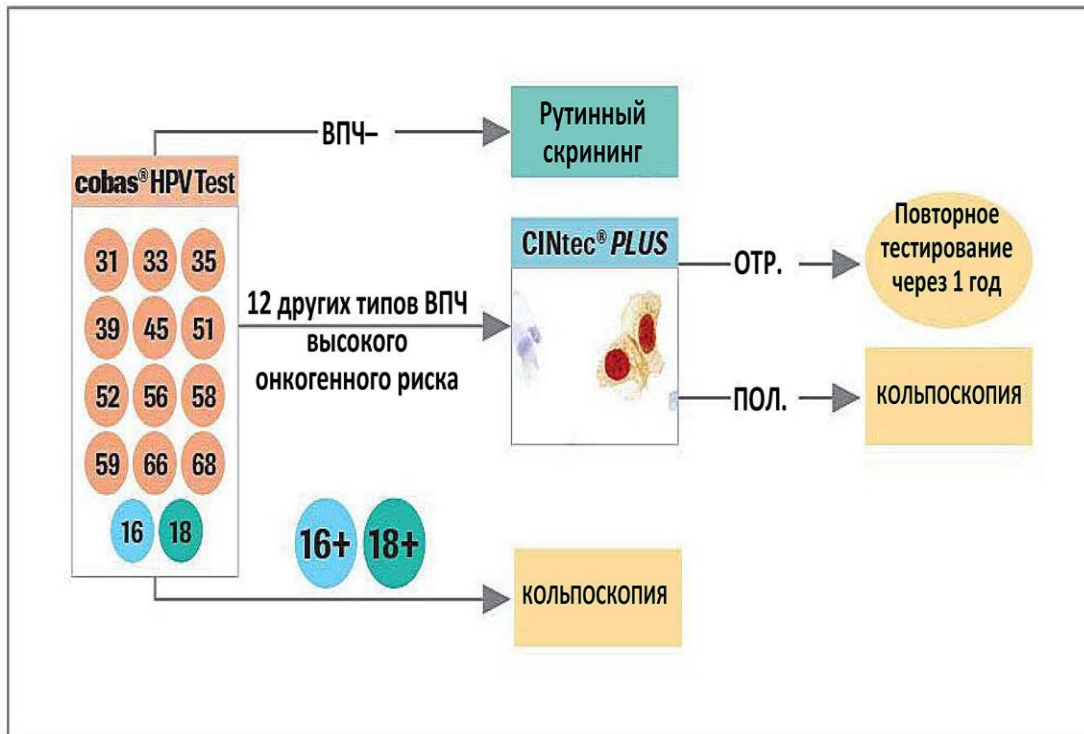
НАИМЕНОВАНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ТЕЛЕФОН			
Результат цитологического исследования №			
Характеристика материала (ЖЦ/ТЦ)		Дата поступления материала	
Качество препарата:		1. адекватный	2. недостаточно адекватный
		3. неадекватный	
1.	Отсутствие внутриэпителиального поражения или злокачественности (NILM по системе TBS)		
1.1.	Цитогарма без особенностей:		
1.1.1.	Клетки плоского и цилиндрического эпителия без патологии		
1.1.2.	Клетки плоского эпителия без патологии		
1.2.	Цитогарма с возрастными и физиологическими изменениями:		
1.2.1.	- пролиферативный тип мазка		
1.2.2.	- атрофический тип мазка		
1.3.	Атрофический кольпит		
1.4.	Пролиферация железистого эпителия		
1.5.	Гиперплазия плоского эпителия		
1.6.	Бактериальный вагиноз		
1.7.	Воспалительный процесс слизистой оболочки (уточнить)		
	вагинит	эктоцервикит	эндоцервикит
	стиль в выраженности		
	Реактивные изменения клеток плоского и цилиндрического эпителия		
	Эпителический фактор		
2.	Возможность или наличие внутриэпителиальных поражений		
2.1.	Единичные клетки плоского эпителия, трактовка которых затруднена (ASC – US по системе TBS)		
2.2.	Атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить высокую степень плоскоклеточного intraepithelialного поражения (ASC – H по системе TBS)		
2.3.	Нерезко выраженные изменения клеток плоского эпителия (LSIL по системе TBS)		CIN I, HPV
2.3.1.	- легкая дисплазия		
2.3.2.	- изменения, характерные для папиллом вирусной инфекции		
2.4.	Выраженные изменения клеток плоского эпителия (HSIL по системе TBS)		CIN II, CIN III, CIS
2.4.1.	- умеренная дисплазия		
2.4.2.	- тяжелая дисплазия		
2.5.	Пролиферация клеток цилиндрического эпителия с признаками атипии (AGC – NOS по системе TBS)		
2.6.	Пролиферация клеток железистого эпителия с признаками атипии, подозрительная на рак (AGC-FN по системе TBS)		
3.	Рак (уточнить форму):		
4.	Другие типы цитологических заключений и дополнения (описание)		





Молекулярные исследования при заболеваниях шейки матки

- Совместное применение цитологического метода и тестов на ДНК ВПЧ значительно снижает риск «проскальзывания» больных через «сеть» цитологического скрининга.



Кабинетный скрининг РШМ
(TruScreen)

1

Отбор пациентов с подозрением на РШМ.

Цитология жидкостная

2

Цитологический анализ

ПЦР на вирус папилломы человека

3

Анализ генного

Гистология

4

Определение вхоли из биоптата (тканей опухоли)

ИГХ

5

Уточнение характера и чувствительности опухоли для определения прогноза ее развития и подбора соответствующей терапии (молекулярный анализ)

Молекулярная биология



Повышение эффективности цитологического метода является немаловажным фактором улучшения скрининга РШМ, для чего необходимо обеспечить высокое качество всех этапов цитологического исследования:



- Развитие сети централизованных цитологических лабораторий, оснащение их современным оборудованием, техникой и программным обеспечением.
- Организация обучения и повышения квалификации всех специалистов, вовлеченных в цитологический скрининг, акушеров, гинекологов, лаборантов и врачей цитологов.
- Совершенствование методов забора цитологического материала (использование специальных приспособлений для получения материала).
- Совершенствование методик окрашивания и приготовления цитологических препаратов, при наличии финансовых возможностей - использование ЖЦ и окрашивания по Папаниколу.
- **Однако, следует помнить о том, что ЖЦ способна улучшить качество цитологических препаратов, но не может заменить хорошо налаженный рутинный цитологический скрининг.**
 - Внедрение этого метода в практику требует дополнительного обучения специалистов и тщательного анализа получаемых результатов, при возможности желательно сочетать традиционный метод и ЖЦ.
- Четко налаженная система обеспечения (внутреннего контроля качества) и внешнего контроля качества работы, нагрузка медицинских технологов и врачей с учетом гигиенических требований к специалистам, работающим с микроскопами и иммерсионной системой.
- Проведение цито-гистологических сопоставлений, наличие «обратной связи» в цепочке гинеколог-цитолог-гистолог и заинтересованности всех специалистов, участвующих в скрининге, в результатах деятельности (своевременном выявлении и целенаправленном лечении репродуктивно значимых инфекций и предраковых состояний, снижении заболеваемости и смертности от РШМ).





Кадровая экономика.

Для чего нам хронометраж в цитологических исследованиях?..

1. Стандартизация и порядок в исследованиях на всех этапах.
2. Расчёт трудозатрат персонала, в зависимости от вида биоматериала и технологии.
3. Понимание оплаты своего персонального труда.



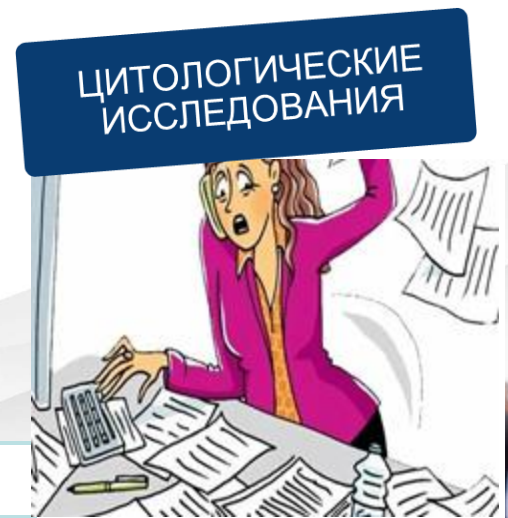


Вспомнить и учесть всё!..

- Расчетные нормы времени включают только время, непосредственно затраченное на анализ, и не являются показателем длительности анализа.
- **За единицу учета цитологического исследования принимается один препарат/ стеклопрепарат 1 локализации.**

(У одного больного может быть приготовлено разное число препаратов. Из обрабатываемой в лаборатории мокроты, жидкостей, а также отпечатков и соскобов операционного материала приготавливают обычно не более 5 препаратов...ВОЗМОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ПО ФАКТУ – ЛЮБОЕ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО)

- В затраты времени одного (первого) препарата включено, кроме микроскопии, время на всю подготовительную и заключительную работу с данным материалом, (консультации с врачами, ознакомление с материалом, составление заключения и внесение его в бланк и т.д.);





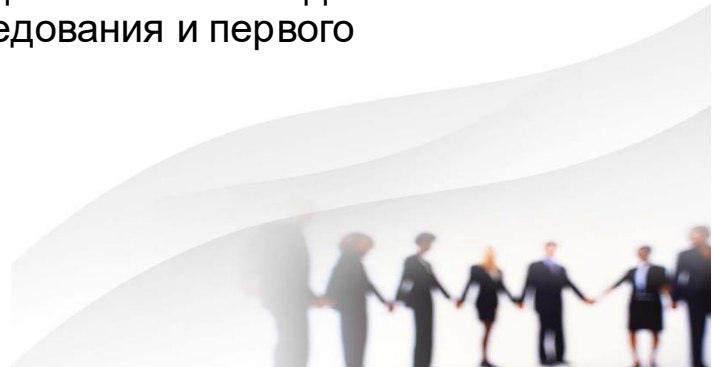
Из Приказа МЗ РФ № 380 /1997г

не зарегистрирован в МИНЮСТе РФ, рекомендателен к применению

- Нормы затрат времени
- рассчитаны на основе проведения хронометража,

который был выполнен в нескольких лабораториях. Осуществлялся хронометраж отдельных элементов труда по заранее составленным картам технологических операций, после чего проводили статистическую обработку данных и расчет затрат времени на каждое исследование. Расчетные нормы времени на клинические лабораторные исследования определены с учетом оптимальной производительности труда медперсонала, обеспечивающей высокое качество исследований.

- Нормы времени разработаны на одно исследование - "единичное" и "каждое последующее", проведение одного изолированного исследования и первого исследования в серии рассматривается как "единичное".





ПРИКАЗ
от 19 февраля 2021 г. N 116н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Цитологическая лаборатория/ физические лица		
1.	Заведующий отделением - врач клинической лабораторной диагностики	1
2.	Врач клинической лабораторной диагностики	1 до 30 диагностических цитологических исследований в день или 1 до 60 цитологических исследований в день с методом автоматизированной жидкостной цитологии или 1 до 60 скрининговых, цитологических исследований в день
3.	Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант	2 на каждого врача клинической лабораторной диагностики (прием, приготовление, окраска всех цитологических препаратов, регистрация); при двухступенчатом просмотре цитологических препаратов до 70 цитологических исследований в день или 1 до 100 цитологических исследований в день методом автоматизированной жидкостной цитологии;

Результат цитологической
верификации диагноза –
установление врачом-специалистом
диагноза онкологического
заболевания.

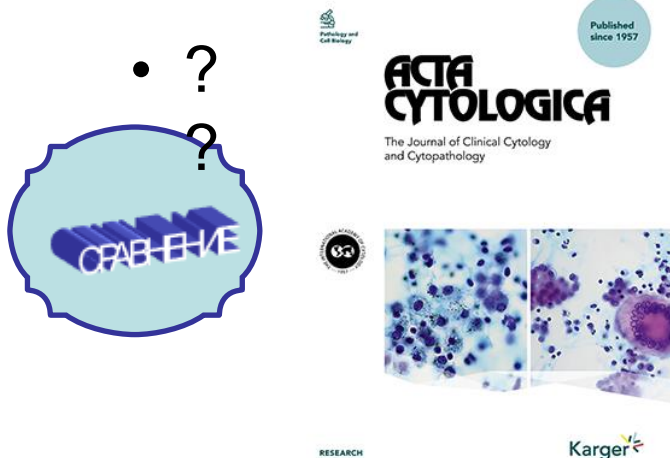
№ 116н
2021г





Как дела у коллег в мире с ЛИМИТОМ КОЛИЧЕСТВА цитопрепаратов?

- *Quality Assurance and risk reduction Guidelines Mody D.R. Acta Cytologica 2000*



B. Workload Limits

66,4 в
день

- In the United States - mandated no more than 100 slides per eight-hour day, prorated at the rate of no more than 12.5 slides an hour.
- Some states, like New York and California, have lower limits, 80 slides at 10 per hour.
- In the United Kingdom the limit is 32 slides per day (recommended by the Code of Practice for Laboratories providing a Cytopathology Service, of the British Society for Clinical Cytology)
- The German Medical Association recommends a maximum of 10 slides per hour for screening cytotechnologists.
- In Italy the workload recommended by the Italian society, Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citopatologia Diagnostica, is a maximum of 50 and a minimum of 25 slides per day.
- In Australia the maximum number of gynecologic slides permitted to be screened per average working day is < 70 per 24-hour period.



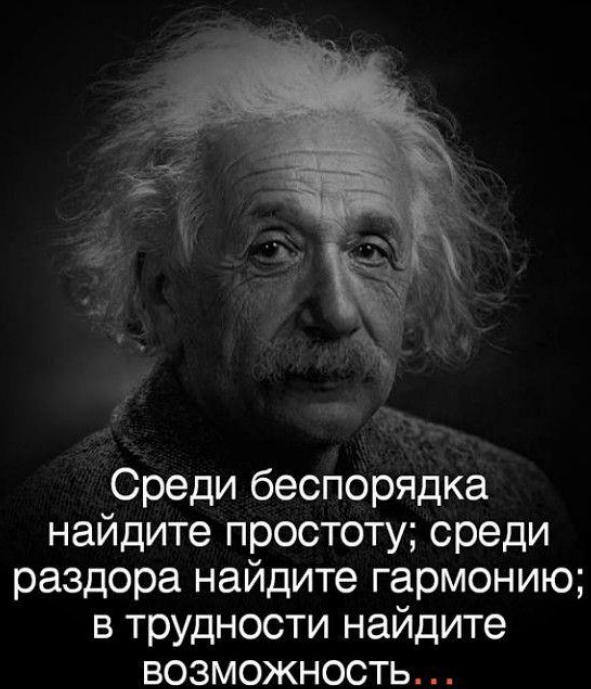
**За каждым диагнозом – стоит
жизнь!**

**За каждым специалистом –
личная ответственность...**





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !



Среди беспорядка
найдите простоту; среди
раздора найдите гармонию;
в трудности найдите
ВОЗМОЖНОСТЬ...

Альберт Эйнштейн



Вострикова Ж.И.